

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

CUESTIONARIO SOBRE LA FORMA CORPORAL (BSQ)

Body Shape Questionnaire (Cooper et al., 1987) · Adaptación Española (Raich et al., 1996)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Cuestionario sobre la Forma Corporal (Body Shape Questionnaire, BSQ)
Sigla / Acrónimo	BSQ
Autoría original	Peter J. Cooper, M. J. Taylor, Z. Cooper & Christopher G. Fairburn (Univ. of Cambridge / Oxford, 1987)
Adaptación en español	Rosa M. Raich, M. Mora, A. Soler, C. Ávila, I. Clos & L. Zapater (1996, Clínica y Salud)
Constructo evaluado	Preocupación insatisfactoria, miedo al incremento ponderal y vergüenza patológica por el propio cuerpo
Población diana	Adolescentes y adultos (especialmente mujeres jóvenes) en evaluación de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA)
Tiempo de aplicación	8 a 12 minutos (autoadministrado)
Estructura y formato	34 ítems graduados en una escala ordinal tipo Likert de 6 puntos (1 = Nunca a 6 = Siempre)
Condiciones de uso	Uso libre para investigación científica y práctica asistencial no comercial citando la fuente original

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

La insatisfacción corporal y la sobrevaloración del peso y la silueta constituyen el núcleo psicopatológico central de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, particularmente de la Bulimia Nerviosa, la Anorexia Nerviosa y el Trastorno por Atracón. Según el influyente modelo transdiagnóstico cognitivo-conductual de Fairburn, Cooper y Shafran, mientras que la mayoría de las personas juzgan su autoestima sobre la base de su rendimiento en diversos dominios vitales (trabajo, relaciones, aficiones), los pacientes con TCA juzgan su valor personal casi exclusivamente en términos de su peso, figura corporal y capacidad para controlarlos.

El BSQ fue diseñado específicamente para cuantificar la intensidad de este fenómeno fenomenológico, explorando la hipervigilancia atencional hacia zonas anatómicas temidas (muslos, caderas, abdomen), la autoevaluación despectiva ante el espejo, la evitación de situaciones donde el cuerpo pueda quedar expuesto (playas, vestirse con ropa ajustada) y el temor catastrófico a engordar.

3. FACTORES Y DIMENSIONES CLÍNICAS DEL BSQ

Dimensión Factorial	Nº Ítems	Rango	Contenido y Operacionalización Clínica
1. Insatisfacción Corporal	14 ítems	14 - 84	Sentimientos de repulsa, vergüenza, autodesprecio físico y deseo vehemente de reducir volumen corporal
2. Miedo al Aumento Ponderal	8 ítems	8 - 48	Pánico obsesivo a ganar peso tras las comidas y obsesión por controlar la báscula
3. Evitación y Ocultamiento	7 ítems	7 - 42	Uso de ropa holgada para taparse, evitación de mirarse al espejo o de desvestirse en público
4. Comparación Social	5 ítems	5 - 30	Comparación física automática y desvalorizante con otras mujeres o figuras mediáticas

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS EN POBLACIÓN ESPAÑOLA

Consistencia interna	Extraordinaria fiabilidad global; alfa de Cronbach $\alpha = 0.95 - 0.97$ en la validación española de Raich et al. (1996) y $\alpha = 0.93$ en población adolescente.
Estabilidad temporal	Fiabilidad test-retest a 4 semanas con coeficiente de correlación de Pearson $r = 0.88$, demostrando consistencia temporal.
Validez convergente	Correlación muy alta con el EDI-2 (subescala de Insatisfacción Corporal, $r = 0.79$; e Impulso por la delgadez, $r = 0.72$) y con el EAT-40 ($r = 0.65$).
Validez discriminante	Diferencia de manera sobresaliente entre pacientes con Bulimia y Anorexia Nerviosa frente a estudiantes universitarias y controles sin patología alimentaria ($p < 0.001$).
Sensibilidad al cambio	Muestra caídas muy significativas tras la reestructuración cognitiva y desensibilización al espejo en terapia cognitivo-conductual.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Marco temporal evaluado	Las 34 preguntas se refieren a los sentimientos y pensamientos tenidos durante las últimas cuatro semanas .
Codificación canónica	Cada ítem se puntúa de 1 a 6: 1 = Nunca ; 2 = Raras veces ; 3 = A veces ; 4 = A menudo ; 5 = Casi siempre ; 6 = Siempre .
Puntuación directa global	Suma aritmética simple de los 34 ítems. Rango teórico posible: 34 a 204 puntos . A mayor puntuación, mayor gravedad psicopatológica.
Advertencia de inversión	Si se utiliza una plantilla impresa donde la columna 1 esté rotulada como "Siempre" y la columna 6 como "Nunca", es obligatorio invertir la codificación (7 - valor) antes de sumar.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación BSQ	Percentil Aprox.	Grado de Preocupación	Significación Clínica y Pronóstico
34 - 80 puntos	< Pc 50	Sin Preocupación Corporal	Actitud normativa hacia la propia figura; satisfacción corporal adaptativa.
81 - 110 puntos	Pc 55 - Pc 75	Preocupación Leve	Leve insatisfacción estética; común en adolescentes; no patológica per se.
111 - 140 puntos	Pc 80 - Pc 90	Preocupación Moderada	Significativa insatisfacción corporal; riesgo de inicio de dietas restrictivas.
141 - 204 puntos	> Pc 90	Preocupación Severa / Extrema	Rango clínico típico de TCA activo (Bulimia / Anorexia); alta angustia vital.

PUNTOS DE CORTE CLÍNICOS EN ESPAÑA (RAICH ET AL.):

- **BSQ > 105 puntos:** Punto de corte diagnóstico óptimo que discrimina entre sujetos de la comunidad y pacientes con Trastorno de la Conducta Alimentaria formal.
- **BSQ > 140 puntos:** Nivel de gravedad crítica que exige intervención especializada inmediata en Unidad de TCA para prevenir conductas purgativas o inanición.

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE ACTUACIÓN ANTE INSATISFACCIÓN CORPORAL Y TCA

Paso 1: Aplicación del BSQ (34 ítems): Calcular la puntuación directa total (34-204).

Paso 2: Si BSQ $\leq$ 80: Descartar insatisfacción corporal como motor de patología alimentaria.

Paso 3: Si BSQ 81 — 110 (Leve): Psicoeducación sobre diversidad corporal y alfabetización crítica en medios de comunicación y redes sociales (Instagram/TikTok).

Paso 4: Si BSQ 111 — 140 (Moderada): Evaluar conductas alimentarias compensatorias encubiertas (vómitos, laxantes, ejercicio compulsivo); pautar TCC para modular el pesaje diario compulsivo.

Paso 5: Si BSQ $>$ 140 (Severa): Derivación prioritaria a Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria (UTCA); protocolo de exposición al espejo con prevención de respuesta de autocritica y terapia de aceptación corporal.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO EN UNIDAD DE TCA

Identificación: Paciente mujer de 19 años, estudiante de Periodismo, remitida por Medicina de Familia tras presentar erosiones dentales linguales e hipopotasemia leve en analítica rutinaria. IMC = 20.8 kg/m².

Evaluación BSQ Inicial: Puntuación Total = **162 / 204** (Preocupación Severa / Extrema).

• Respuestas de máxima puntuación (6 = Siempre): pellizcarse los muslos para verificar grosor, evitar mirarse al espejo desnuda, sensación de vergüenza tras comer cualquier carbohidrato, miedo atroz a engordar e hipervigilancia atencional ante los cuerpos de otras chicas en clase.

Diagnóstico: Bulimia Nerviosa con atracones objetivos nocturnos y vómitos autoprovocados como mecanismo compensatorio.

Plan Terapéutico: TCC ambulatoria específica para Bulimia (Fairburn): regularización del patrón de 5 comidas diarias, eliminación del uso de la báscula domiciliaria, reestructuración de la sobrevaloración de la figura corporal y exposición graduada al espejo sin juicio estético.

Reevaluación a los 6 meses: La puntuación BSQ disminuyó a **78 / 204** (Sin preocupación patológica, reducción de 84 puntos), con remisión completa de atracones y purgas.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas y Riesgos Somáticos:

- **Alteraciones Iónicas Severas:** Vómitos autoprovocados en bulimia conllevan hipopotasemia ($K^+ < 3.0$ mEq/L) y riesgo de arritmias ventriculares fatales.
- **Desnutrición Grave:** Si BSQ $>$ 140 coexiste con IMC $<$ 15, ingreso hospitalario urgente por riesgo de síndrome de realimentación.

Diagnóstico Diferencial:

- **TCA vs. Trastorno Dismórfico Corporal (TDC):** En el TDC la preocupación se focaliza en un defecto facial o cutáneo específico, no en el peso global o silueta.
- **Vigorexia / Dismorfia Muscular:** En varones jóvenes, la insatisfacción puede ser por falta de masa muscular (evaluar con escalas de muscularidad).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Cooper, P.J., Taylor, M.J., Cooper, Z., & Fairburn, C. G. (1987). The development and validation of the Body Shape Questionnaire. *International Journal of Eating Disorders*, 6(4), 485-494. [https://doi.org/10.1002/1098-108X\(198707\)6:4<3.0.CO;2-O](https://doi.org/10.1002/1098-108X(198707)6:4<3.0.CO;2-O)
- Raich, R. M., Mora, M., Soler, A., Ávila, C., Clos, I., & Zapater, L. (1996). Adaptación de un instrumento de evaluación de la insatisfacción corporal. *Clínica y Salud*, 7(1), 51-66.
- Fairburn, C. G., Cooper, Z., & Shafran, R. (2003). Cognitive behaviour therapy for eating disorders: a "transdiagnostic" theory and treatment. *Behaviour Research and Therapy*, 41(5), 509-528.
- Evans, C., & Dolan, B. (1993). Body Shape Questionnaire: derivation of shortened "alternate forms". *International Journal of Eating Disorders*, 13(3), 315-321.